



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 27-06-2025 9:13:49

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Cristian Andrés Montero González	Rut : 15.347.325-0	N° Archivo : 2106275	N° Epicrisis
Edad : 43a 1m 6d	Fecha Nacto : 21/05/1982	Sexo : Masculino	445920
Dirección : Alpatocal2116 2116	Comuna : La Pintana	Teléfono : 963378485	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización	Fecha Ingreso : 27/06/2025	03:22	Días Estadía : 1
Unidad de Egreso : Emergencia Adulto	Fecha Egreso : 27/06/2025	09:06	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Convulsión

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

REA
Paciente de 43 años

MC: Convulsión

AM: Epilepsia secundaria a TEC
A.Qx: TEC craniectomía?
Fcos: Levetiracetam 500mg cada 12 horas, Zopiclona PM
Alergia: Niega
mRs 3-4

Paciente traído por SAMU tras presentar convulsiones tonico clónicas a las 21h aprox, presenciada por hermano, no sabe cuanto duró, luego habría presentado otro episodio, sin clara recuperación. Cuando llegó SAMU cerca de las 22h habría estado convulsionando, administran 5mg Midazolam + 10mg de Diazepam, con lo que cede.

Plan:
- Ex. Laboratorio
- Carga Fenitoina 1200mg IV
- IC neurología

NEUROLOGIA (C. Silva)
D, R3-4, con antec TEC abierto complicado grave (2021 y 2022) con secuelas cognitivas, motoras y epilepsia focal.
Usuario LEV 500mg cada 12h, hoy ingresa tras presentar convulsión sin retorno al basal. Se intenta yugular con MDZ en extrahosp sin exito.

A la ev vigil, orientado, cooperador. Refiere olvido de dosis PM. Niega consumo sustancias, niega intercurr. medica.
Pasando PHT carga (conversada via telefonica).

Examen neuro: Vigil, orientado en tiempo, parcial en espacio. Nomina, repite y obedece ordenes simples. PC: midriasis
Fecha Epicrisis : 27/06/2025 09:13

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 27-06-2025 9:13:49

Página 2 de 2

reflectica, mirada central, leve PFC izquierda. Motor: hemiparesia izquierda M4 BQ. A der M5.
Resto sin alteraciones.

Dg. estado epileptico yugulado. Secundario a mala adherencia a tratamiento
- Completar carga con Fenitoina 1.2g ev en infusión pasando lento
- TC encefalo +angio y exam lab
- Carga oral con Levetiracetam 2g, dejar dosis de mantención 500mg - 1g.
Observar. Al alta asegurar stock de fármaco y continuar controles en H. Base (HPH).

Diagnóstico de Egreso

Epilepsia -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Estable

Plan Post Alta

Reposo relativo
Regimen común
Mantener medicamentos de uso habitual

MEDICAMENTOS:

- Levetiracetam 500mg en la mañana - 1 g en la noche

Mantener controles en Hospital Padre Hurtado. Presetar interconsulta

Reconsultar en Urgencia en caso de fiebre, dificultad para hablar o mover alguna parte del cuerpo, convulsiones que no ceden luego de 5 min o cuando estime necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Común

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Bec. Adolfo Kahler Catalan

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 27/06/2025 09:13

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:50

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar